Autos: 0800870-69.2023.8.12.0010
Ação: Procedimento Comum Cível - Oncológico
Autor:Arnaldo Nardon
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

SENTENÇA

Arnaldo Nardon propôs ***"Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência"*** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul,** todos qualificados na inicial (p. 1).

Em síntese, a parte autora argumentou que é portadora de fibrose pulmonar idiopática (CID I J84:1) e carcinoma pulmonar de pequenas células, sendo-lhe receitado o medicamento OFEV 150mg, porém o medicamento não é disponibilizado pelo SUS e não possui condições financeiras para custear o gasto com o medicamento. Procurou o plano de saúde para fornecimento do medicamento, mas não teve seu pleito atendido. Não há outra medicação no SUS com mesma eficácia.

Com base nesses fatos, formulou pedido para concessão antecipada da tutela de urgência, com ordem para que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Fátima do Sul cumpram imediatamente com a obrigação de fornecer o medicamento receitado, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas. O pedido fial consiste na confirmação da tutela de urgência. Requereu, também, o benefício da gratuidade. Deu à causa o valor de R$ 16.490,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa reais).

A petição inicial (p. 1-14) veio acompanhada de procuração (p. 15) e outros documentos (p. 16-43).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável ao pedido (p. 47-56).

Na decisão de p. 57-60, o juízo deferiu a tutela de urgência e concedeu assistência judiciária gratuita à autora.

Em contestação (p. 75-97), o Estado de Mato Grosso do Sul aventou preliminar de inclusão da União no Polo Passivo e inépcia da inicial. No mérito, aduziu ser responsabilidade da União pelo fornecimento de tecnologias não incorporadas no SUS; necessidade de aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.65.156/RJ (TEMA 106). Diante do exposto, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, a fim de que: a. seja promovida a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, em observância à decisão proferida no RE 1366243/SC (tema 1234) b. seja indeferida a petição inicial, em razão da sua inépcia, quanto ao pedido genérico e indeterminado formulado pela parte autora. Quanto ao mérito, requer seja julgado improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, em razão da não preenchimento dos requisitos fixados pelo tema 106 do STJ. No caso de procedência, requer: a. seja direcionado à UNIÃO o cumprimento da obrigação relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, garantindo-se ao Estado o direito de ressarcimento no caso de custeio com recursos próprios. b. seja estipulada a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99. c. sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade com base no art. 85, §8º, CPC. d. no caso de execução forçada do julgado, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde. e. em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em nome e CNPJ do Estado. f. seja indeferido o pedido de restituição de eventuais valores despendidos pela parte autora para aquisição do medicamento objeto da demanda.

Interposto agravo de instrumento pela parte requerida (p. 98).

Acordo firmado entre os Entes requeridos para o cumprimento da tutela provisória de urgência (p. 109-110).

O Município de Fátima do Sul apresentou contestação (p. 112-119), aduzindo preliminar de falta de interesse de agir. Quanto ao mérito fundamentou acerca da regionalização e hierarquização do SUS; necessidade de redirecionamento da obrigação de fazer ao Entre administrativamente competente (RE 855.178; inaplicabilidade de condenação do Ente Público de medicamento não incorporado pelo SUS; inaplicabilidade do Ente Público em honorários sucumbenciais nas ações que versem sobre o direito à saúde. Por todo o exposto, requer o ente municipal o recebimento da presente contestação, por tempestiva, para que sejam julgadas procedentes as preliminares de falta de interesse de agir da parte autora e ilegitimidade passiva, com a extinção da ação, sem resolução de mérito. No mérito, requer seja julgada improcedente o pleito de condenação do Município de Fátima do Sul a disponibilizar o medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg para ARNALDO NARDON. Subsidiariamente, na remota hipótese de procedência da ação, requer seja determinado o rateio das despesas do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg entre os requeridos a fim de que, sendo o caso, o Município busque o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos. Pugna pela não condenação do Município ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência, pela indevida provocação da jurisdição. Juntou documentos (p. 120-123).

Impugnação à contestação (p. 127-142; doc. p. 143-191).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nossos Tribunais assim têm se pronunciado a respeito do julgamento antecipado: "*Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder*". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: "*O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art.130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia*" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).

Preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda:

Denota-se dos autos que a pretensão da parte autora é direcionada ao fornecimento de tratamento médico não padronizado em atos normativos do SUS.

Na hipótese desse jaez, acerca da legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre o fornecimento de tratamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde – hipótese dos autos –, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no RE n.º 1.366/243 (Tema 1234), estabelecendo os seguintes parâmetros:

> *(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> *(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
>
> *(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.*

Nessa ordem de ideias, considerando que a pretensão da parte autora consiste na dispensação de tratamento não padronizado, a presente demanda deve

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

ser processada e julgada pelo Juízo estadual, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ***PRELIMINAR – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REJEITADA*** *– MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS E OFF LABEL – APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.* ***As demandas relativas a tratamentos médicos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União Federal no polo passivo.*** *Preliminar de inclusão da União no polo passivo rejeitada. O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nas demandas em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde, devem ser observadas as teses firmadas no REsp n.º 1.657.156/RJ: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, não houve a comprovação por meio de laudo médico fundamentado da imprescindibilidade dos medicamentos, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade que aflige o paciente. Ademais, o medicamento manipulado pleiteado não possui registro na Anvisa. Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária prejudicada.*
*(****TJMS****. Apelação Cível n. 0801358-29.2022.8.12.0052, Anastácio, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 25/09/2023, p: 26/09/2023)*

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ***PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – REJEITADAS*** *– MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002/STF – RECURSOS VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Não caracteriza sentença genérica aquela que julga procedente a obrigação de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

fornecer o tratamento de saúde pleiteado na inicial, providenciando procedimento cirúrgico e todos os atos relacionados ao atendimento do paciente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. ***As demandas relativas a tratamentos médicos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Preliminar de inclusão da União no polo passivo rejeitada.*** *O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A invocação genérica do princípio da reserva do possível não exime o ente público do dever de observar as obrigações decorrentes de lei. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1002/STF). Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Sentença retificada em Remessa Necessária.*
*(**TJMS**. Apelação Cível n. 0801717-05.2022.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 25/09/2023, p: 26/09/2023)*

Portanto, **rejeito** a preliminar suscitada.

Preliminar de inépcia da inicial:

O Estado requerido suscita preliminar de inépcia da inicial, aduzindo que a requerente formulou pedido genérico.

Contudo, sem razão.

Isso porque, o inciso II do § 1º do art. 324 do Código de Processo Civil, permite a formulação de pedido genérico na ação em que se busca tratamento de saúde, por estar tal tratamento sujeito a constantes transformações em razão das modificações do quadro clínico do paciente. Verbis:

"Art. 324. O pedido deve ser determinado.

[...]

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

[...]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

> *II quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;"*

Compulsando os autos, denota-se que a requerente pretende o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que a assiste.

Como se vê, a pretensão consiste no fornecimento de medicamento relacionado ao seu tratamento.

Por essa razão, com amparo no art. 324, § 1º, II, do CPC, é possível a determinação do fornecimento do tratamento conforme a prescrição médica, tal como se operou no presente caso.

Colhe-se, a respeito, a posição desta Corte:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –* ***PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL (PEDIDO GENÉRICO) – AFASTADA*** *– PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU DE REDUÇÃO DO SEU VALOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.* ***I. É possível a formulação de pedido genérico na ação em que se busca tratamento de saúde, por estar tal tratamento sujeito a constantes transformações em razão das modificações do quadro clínico do paciente.*** *II. Não deve ser conhecida, por ausência de interesse recursal, a alegação relacionada à exclusão da multa ou redução de seu valor, uma vez que a sentença sequer a arbitrou. III. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.*
> *(****TJMS****. Apelação Cível n. 0800651-24.2021.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 09/12/2021, p: 14/12/2021)*

Cumpre ressaltar, ademais, que o pedido genérico somente se caracteriza quando há impossibilidade de defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

Logo, **rejeito** a preliminar.

Preliminar de falta de interesse de agir:

O Município de Fátima do Sul teceu argumentação no sentido de que não restou comprovada a negativa de atendimento ao pedido do autor em âmbito administrativo, necessária para configurar a pretensão resistida à lide, de modo que deve ser declarada a ausência de interesse de agir e, consequentemente, extinto o processo sem julgamento do mérito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

Sem razão o postulado pela Fazenda Pública Municipal.

Apesar de não existir prova documental no sentido de que a requerente recebeu resposta negativa à concessão dos insumos pleiteados no âmbito administrativo, tal fato não pode lastrear a extinção do presente processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

É certo que em toda ação o provimento jurisdicional pleiteado deve ser o necessário e o adequado para resolver o problema aventado, sob pena de que, partindo da situação apresentada pelo autor e do provimento efetivamente solicitado, a atividade jurisdicional não caminhe para um resultado útil.

O interesse processual repousa, assim, sobre o binômio necessidade/adequação, configurando-se, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, *"como aptidão a propiciar o bem ao demandante se ele tiver razão", de modo que "não existe quando o sujeito já dispõe do bem da vida que vem a juízo pleitear e quando o provimento pedido não é mais, ousimplesmente não é, capaz de propiciar-lhe o bem"* (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 5ª edição, Malheiros, p. 304).

No caso, a preliminar de ausência de interesse de agir não se sustenta, porque já é entendimento há tempo consolidado de que não se revela necessário o esgotamento da via administrativa para que o particular se utilize da prestação jurisdicional.

Como é sabido, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cujo conteúdo principiológico encontra-se positivado no art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal. Dessume-se que é dever do Estado conhecer e julgar as demandas postas à sua apreciação, assegurando o direito substancial do autor o remédio processual respectivo.

Ainda mais quando se trata de bem jurídico de fundamental importância como é o caso do direito à saúde, corolário direto e recíproco do direito à vida, de modo que não há impedimento para que a parte busque junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido sem quaisquer condicionamentos.

Vê-se que o autor ingressou com uma demanda de obrigação de fazer, que se revela útil, necessária e adequada para o bem da vida pleiteado. Se faz jus ou não à obrigação pleiteada é questão atinente ao mérito e como tal será analisado.

Dessa maneira, não há que falar em esgotamento da via administrativa para obtenção de eventual direito, não estando a prestação jurisdicional vinculada a esta condição.

Diante disso, **rejeito** a preliminar de falta de interesse de agir.

Inexistindo demais preliminares a serem apreciadas, passo ao exame direto do mérito.

Mérito:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

Trata-se de ação de conhecimento na qual a requerente aduz padecer de fibrose pulmonar idiopática (CID I J84:1) e carcinoma pulmonar de pequenas células, sendo-lhe receitado o medicamento OFEV 150mg, porém o medicamento não é disponibilizado pelo SUS e não possui condições financeiras para custear o gasto com o medicamento. Procurou o plano de saúde para fornecimento do medicamento, mas não teve seu pleito atendido. Não há outra medicação no SUS com mesma eficácia.

O pedido esboçado pela autora merece acolhimento.

A apreciação do pedido de disponibilização de medicamentos exige cautela, sob pena de imputar consequências irremediáveis ao jurisdicionado e/ou interferir na esfera de competência do Executivo, porquanto, em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médica e farmacêutica.

De início, cumpre anotar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pleito, relatando, em resumo (p. 56), que:

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que o paciente está sendo atendido por médico particular/ convênio médico.

Considerando que Esilato de Nintedanibe não está padronizado na RENAME 2022.

Considerando que novas modalidades terapêuticas, como a pirfenidona e o nintedanibe, ainda necessitam de uma avaliação mais precisa quanto ao impacto na sobrevida dessa população (portadores de fibrose pulmonar).

Considerando que o transplante pulmonar é considerado, até o presente momento, como a única alternativa terapêutica capaz de impactar de maneira significativa a progressão da doença, e sua indicação deve ser sempre discutida em casos cujo risco de insuficiência respiratória e mortalidade estiver próximo.

Considerando as evidências científicas disponíveis, bem como a recomendação da CONITEC pela não incorporação do Nintedanibe.

Considerando que o Nintedanibe pode ser utilizado no tratamento do paciente, conforme indicado pela diretriz brasileira (recomendação condicional; qualidade de evidência moderada), porém a evidência disponível apresenta incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida, apresenta razão de custo-efetividade alta.

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Esilato de Nintedanibe.

Ressalta-se que, apesar do parecer desfavorável do NAT, analisando detidamente os documentos que acompanham a inicial, restou comprovado que o pedido comporta deferimento, sendo demonstrada a imprescindibilidade da medicação requerida e o esgotamento das alternativas fornecidas pela rede pública.

Seguindo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema repetitivo n. 106, verifica-se que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA (p. 34, itens IV).

A parte requerente mencionou que não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento, o que restou devidamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

comprovado através dos documentos da p. 34, eis que trata-se de medicamento de alto custo, de aproximadamente R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Quanto à imprescindibilidade dos medicamentos, tem-se que embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável (p. 32, item XI), o medico que assiste o autor relatou com detalhes a imprescindibilidade do medicamento (p. 27-28):

> Paciente vem apresentando piora clínica e tomográfica, atualmente em TC de tórax 20/12/2022 mostrando evidente progressão da doença, o que faz necessário o início urgente da medicação.
> - Sobre o comportamento da doença e indicação do tratamento com antifibrótico: A mediana de sobrevida da FPI é de 2 a 5 anos, mas estimativas individuais são difíceis de fazer. O curso clínico da FPI é altamente variável. O sintoma principal é a dispneia, seguido por tosse seca. As provas de função pulmonar na FPI geralmente apresentam redução dos volumes pulmonares, elevação dos fluxos expirados, elevação da relação VEF1/CVF e redução da DCO. E a troca gasosa vai sendo progressiva e irreversivelmente prejudicada, inicialmente aos esforços e, posteriormente, ao repouso com necessidade de suplementação de oxigenoterapia domiciliar. Portanto, o que se preconiza na literatura é que, pela sobrevida pobre, se inicie o tratamento no momento do diagnóstico a fim de preservar a melhor função pulmonar em que o paciente já se encontra. O tratamento farmacológico da FPI inclui duas drogas testadas em estudos clínicos multicêntricos, randomizados e placebo-controlados: pirfenidona e nintedanibe. Esses fármacos se mostraram eficazes em reduzir a progressão do declínio funcional pulmonar, medido através da capacidade vital forçada (CVF). Portanto o tratamento da FPI com qualquer uma das drogas antifibróticas hoje disponíveis não é paliativo, mas também não cura a doença. Não há estudos de tratamento e sobrevida na FPI, porque se trata de uma doença rara e para estudos com essa finalidade seria necessário uma grande amostra de pacientes. No entanto, já há estudos de vida real, que, após acompanhar a coorte tratada desde os estudos originais com as duas drogas até hoje, mostraram diminuição significativa do risco de morte. Outro ponto importante a considerar, é que em se tratando de pacientes na grande maioria idosos, o transplante pulmonar (de indicação no Brasil < 60 anos) não é possível de ser realizado facilmente. E, para aqueles que conseguem entrar na indicação do transplante, o uso de antifibrótico também está indicado para tentativa de preservação da função pulmonar em fila de espera.

Apesar de os requeridos alegarem ausência de comprovação do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como não demonstração de sua ineficácia, o médico subscritor do mencionado laudo informou, de forma explícita, que não há espaço para a utilização de remédios fornecidos pela rede pública de saúde e constante da lista do RENAME (p. 28):

> Os demais tratamentos disponíveis no SUS como corticoide, acetilcisteina e imunossupressores já estão proscritos na FPI, como demonstrado em estudos controlados.
> - Portanto, como foi exposto acima, o paciente em questão tem indicação do uso do antifibrótico prescrito: Nintedanibe 150mg - 1 comprimido de 12 em 12 horas. Não existe outro tratamento disponível para esse caso, principalmente pela evolução progressiva da doença, como citado no texto. O Nintedanibe possui registro na ANVISA sob número 103670173.

Sendo assim, consignado pelo médica que o uso dos medicamentos fornecidos pela rede pública não possuem ação eficaz ao caso da requerente, devendo ser utilizados em conjunto o fármaco prescrito, ora pleiteado (Ofev), tem-se que tal medicamento realmente é o mais eficaz ao tratamento da parte autora.

Nesse caminhar, considerando a essencialidade do medicamento prescrito para o adequado tratamento da parte autora, entendo que não é prudente privar a parte requerente da medicação receitada pelo profissional de saúde que a acompanha, conhece as peculiaridades de seu quadro clínico e suas condições pessoais, tem primazia na escolha dos medicamentos mais adequados ao tratamento e certamente busca o melhor para contenção da patologia.

Nesse sentido, descabe o argumento de que o médico está restrito a prescrever os medicamentos e tratamentos previstos nos Protocolos Clínicos do SUS ou aqueles constantes na RENAME, tendo em vista que o Código de Ética Médica prevê a liberdade do profissional em indicar o melhor tratamento que aprouver ao paciente, bem como deve aquele usar de todos os meios ao seu alcance para efetivar o direito à saúde, restando demonstrado no caso concreto que a médica bem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

fundamentou os motivos pelos quais prescreveu medicamentos diferentes dos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde.

Cumpre consignar que, embora a prescrição médica não goze de presunção absoluta da necessidade do tratamento indicado, tem-se como suficiente para fins de procedência do pedido inaugural, ainda mais quando não demonstrado pela parte contrária a ocorrência de erro ou falha de diagnóstico, de modo a desconstituir o direito autoral.

Assim, não tendo o juiz o conhecimento técnico acerca dos tratamentos pleiteados, bem como a evolução do quadro de saúde da paciente, com a devida vênia, deve atender à determinação médica.

Quanto à idoneidade do posicionamento do NAT, é sabido que tal núcleo de apoio foi criado com a finalidade assessorar o Poder Judiciário Estadual, contribuindo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo órgão de natureza consultiva.

Portanto, sua função é conferir ao julgador maiores elementos técnicos necessários ao desfecho das lides, sem que o magistrado esteja vinculado aos seus pareceres, os quais são isentos de qualquer parcialidade.

Seguindo tal linha intelectiva, não devem prevalecer as orientações do NAT em situações em que resta demonstrada a imprescindibilidade justificada para a utilização de medicamentos diversos do protocolo clínico estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tal como ocorreu no caso em tela.

Nesse aspecto, percebe-se do conjunto dos autos que o procedimento objeto do pedido inequivocamente é de natureza essencial ao caso da requerente, o que recomenda o afastamento da conclusão negativa do parecer confeccionado pelo NAT, sendo possível fazê-lo com fulcro no artigo 479 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, *in verbis*:

> *"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".*

No mais, cumpre acrescentar que a falha na distribuição de recursos para os vários ramos da saúde pública não pode nem deve servir de justificativa para a violação do direito constitucional da parte autora, ainda mais no presente caso, em que existe prova material, firmada por médico e corroborada em juízo, noticiando a necessidade do medicamento.

Além disso, normas puramente administrativas e questões políticas, como ausência de remédios necessários na lista do ReNAME, também não podem servir de óbice à fruição do direito fundamental em questão, repita-se, de estatura constitucional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

E, nesse contexto, uma vez verificado que a negativa de fornecimento em última análise fere o direito à dignidade e à saúde, resguardados a todos os cidadãos pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento do pedido.

Neste sentido tem sido o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – NÃO CONHECIDA - MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO - ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART 196, DA CF*** *– PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO TAO SOMENTE DO MUNICÍPIO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E MUNICÍPIO DE JARDIM CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se conhece da parte do recurso que se refere à necessidade de incluir a União no polo passivo, diante da ocorrência da preclusão, uma vez que a matéria já foi decidida anteriormente, sendo defeso ao juiz proferir nova decisão a respeito do tema, conforme dispõe o art. 505 do CPC. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental a todas as pessoas, é indissociável do direito à vida, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, em favor de pessoa necessitada, nos termos do artigo 196, da CF.* ***Comprovado, por meio de laudo médico, que de maneira fundamentada e circunstanciada demonstra a necessidade do medicamento, bem como a incapacidade financeira de arcar com o seu custo e a existência de registro na ANVISA, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento do fármaco Nintedanibe (OFEV), por se encontrarem presentes os requisitos descritos no REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema n.º 106).*** *Não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal quando a pretensão de exclusão/redução, objeto da impugnação, foi favorável ao Município apelante O Estado de Mato Grosso do Sul não deve suportar o pagamento de honorários de sucumbência quando a parte adversa for patrocinada pela Defensoria Pública, por haver nítida confusão entre credor e devedor. Em contrapartida, é possível a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual n. 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.*
*(**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0800741-26.2021.8.12.0013, Jardim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 21/09/2022, p: 22/09/2022)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.

Logo, diante de todo esse contexto fático e jurídico, é patente a viabilidade do pedido esboçado na inicial.

Quanto à imposição de multa cominatória, trata-se de meio coercitivo e sub-rogatório utilizado para o alcance do cumprimento da decisão judicial, prevista nos arts. 536 e 537 do CPC.

Além disso, cumpre frisar que a multa fixada poderá ser modificada ou até excluída pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, conforme inteligência do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivo:

Posto isso, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **procedente** o pedido, para o fim de **condenar** os requeridos **Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Fátima do Sul**, **a fornecerem o medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg (Ofev 150mg), conforme prescrição médica (p. 26), no prazo máximo de 10 (dez) dias** a partir da intimação, s**ob pena de sequestro de verba pública suficiente à aquisição do medicamento pela rede particular.** Assim, torna-se definitiva a medida liminar concedida anteriormente (p. 57-60).

Em observância ao art. 24 da Lei Estadual 3.779 de 2009, ficam os requeridos isentos do pagamento de taxa judiciária.

Diante da sucumbência integral, condeno o Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Fátima do Sul ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não há razão para majoração do patamar mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, ante a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelos profissionais e o tempo na prolação da sentença.

Publique-se a Sentença, registrada automaticamente pelo SAJ..

Intime-se a PGE, via SAJ, dando-se-lhes vista dos autos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu Advogado, via DJ.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo modificação do julgado, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Fátima do Sul, 02 de outubro de 2023.

Vitor Dias Zampieri
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 02/10/2023 às 20:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800870-69.2023.8.12.0010 e código C18bxEiW.